

TEMA 9.60 • RESPIRATORIO

Otras Causas de Disfonia Aguda

PERFIL EUNACOM 1.05.1.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El **Asma Bronquial** es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas caracterizada por una **hiperreactividad bronquial** y una obstrucción variable al flujo aéreo, que es total o parcialmente reversible, ya sea de forma espontánea o con tratamiento.

Fisiopatología y Causas

El asma se produce fundamentalmente por una respuesta exagerada del árbol bronquial ante diversos estímulos.

- **Hiperreactividad bronquial:** Es el sello distintivo de la enfermedad. Se traduce en episodios de **broncoconstricción** e **hipersecreción** de mucus.
- **Mediación inmunológica:** En muchos pacientes (aunque no en todos), la reacción está mediada por la **Inmunoglobulina E (IgE)**, vinculada a respuestas de tipo alérgico.
- **Remodelación:** Un asma mal controlado de larga data puede llevar a cambios estructurales permanentes en la vía aérea, evolucionando hacia un daño pulmonar crónico similar al **EPOC**.

NOTA CLÍNICA

La fisiopatología del asma implica una inflamación crónica de la mucosa bronquial donde participan mastocitos, eosinófilos y linfocitos T. Esta inflamación causa la hiperreactividad característica ante gatillantes ambientales.

Cuadro Clínico

La clínica del asma es esencialmente **recurrente y paroxística**. Los síntomas varían en intensidad y frecuencia a lo largo del tiempo.

Síntomas Principales

- **Tos:** Es el síntoma más frecuente. A menudo es el único síntoma en variantes de "tos asmática". - **Disnea:** Dificultad respiratoria que aparece habitualmente en crisis. - **Sibilancias:** Ruido silbante durante la espiración. - **Opresión torácica:** Sensación de falta de aire o pecho apretado.

Desencadenantes y Patrones

- **Predominio nocturno:** Los síntomas suelen exacerbarse en la noche o madrugada, frecuentemente por la exposición a alérgenos en el dormitorio (como los ácaros del polvo). - **Ejercicio:** Es muy común el asma inducido por ejercicio. Típicamente, los síntomas no aparecen *durante* el esfuerzo, sino **al descansar después de finalizar la actividad**. - **Infecciones virales:** Son los principales gatillantes de exacerbaciones o crisis asmáticas. - **Otros:** Aire frío, risa, contaminantes ambientales y alérgenos específicos.

Examen Físico

Es fundamental entender que, entre las crisis, el examen físico del paciente asmático suele ser **completamente normal**. Durante una crisis o en pacientes con mal control, podemos encontrar:

- **Sibilancias:** El signo más característico a la auscultación.
- **Roncus:** Ruidos de tonalidad más baja que también indican obstrucción.
- **Aumento del diámetro anteroposterior del tórax:** Signo de atrapamiento aéreo crónico.
- **Hipersonoridad a la percusión:** Debido a la hiperinsuflación pulmonar.
- **Disminución del murmullo pulmonar:** En casos de obstrucción muy severa (tórax silente), lo cual es un signo de extrema gravedad.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Un "tórax silente" en un paciente con crisis asmática severa es un signo de insuficiencia respiratoria inminente. La ausencia de sibilancias en un paciente con gran esfuerzo respiratorio indica que el flujo de aire es insuficiente incluso para generar ruido.

Diagnóstico y Pruebas Complementarias

El diagnóstico del asma es **fundamentalmente clínico**. Una historia sugerente de crisis recurrentes de tos, sibilancias y disnea, que responden a broncodilatadores, es altamente orientadora. Sin embargo, se requiere objetivar la obstrucción y su reversibilidad.

1. Espirometría

Es el examen de elección para el diagnóstico. Busca demostrar un **patrón obstructivo reversible**. - **Criterio de reversibilidad:** Se considera positivo si tras la administración de un broncodilatador (salbutamol) hay un aumento del VEF1 (Volumen Espiratorio Forzado en el primer segundo) de al menos un **12% y 200 ml**.

2. Test de Provocación con Metacolina

Se utiliza cuando la sospecha clínica es alta pero la **espirometría basal es normal** (común en asma intermitente). - Se administra metacolina (un bronconstrictor) en dosis crecientes. - Es positivo si se produce una caída del 20% o más en el VEF1. - **Importante:** Solo se realiza si el paciente NO está obstruido al momento del examen.

3. Flujo Espiratorio Máximo (PEF - Peak Expiratory Flow)

Es una medición sencilla y portátil. Permite al paciente monitorizar su función pulmonar en casa y es útil para evaluar la variabilidad diaria del flujo aéreo.

4. Radiografía de Tórax

Habitualmente es **normal**. Se solicita principalmente para descartar complicaciones (neumonía, neumotórax) o diagnósticos diferenciales. En crisis, puede mostrar signos de atrapamiento aéreo: - Aplanamiento de las cúpulas diafragmáticas. - Horizontalización de las costillas. - Aumento del espacio retroesternal.

TABLA 9.60.1: EXAMEN VS UTILIDAD PRINCIPAL

EXAMEN	UTILIDAD PRINCIPAL	HALLAZGO CARACTERÍSTICO
Espirometría	Confirmación diagnóstica	Patrón obstructivo reversible con BD
Test Metacolina	Pacientes con espirometría normal	Demuestra hiperreactividad bronquial
Radiografía	Descartar diagnósticos diferenciales	Hiperinsuflación (o normal)
Prick Test	Identificar desencadenantes	Reacción de hipersensibilidad a alérgenos

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Regla de oro para el examen: - Si el paciente llega **obstruido** (con síntomas actuales) $\rightarrow$ Pide **Espirometría**. - Si el paciente está **asintomático** ahora (pero tiene historia de crisis) $\rightarrow$ Pide **Test de Metacolina**.

Riesgos y Complicaciones

- El asma no tratada o mal controlada conlleva riesgos significativos:

- **Calidad de vida:** Limitación de la actividad física y ausentismo laboral/escolar.
- **Exacerbaciones:** Riesgo de hospitalizaciones, ingreso a UCI y necesidad de ventilación mecánica.
- **Daño Estructural:** Evolución hacia una obstrucción fija e irreversible de la vía aérea.
- **Efectos secundarios del tratamiento:**
 - - **Beta-agonistas (Salbutamol):** Taquicardia, temblor fino, hipokalemia.
 - - **Corticoides:** Si se usan de forma sistémica crónica, riesgo de síndrome de Cushing, osteoporosis, diabetes e hipertensión. Los corticoides inhalados (pilar del tratamiento) tienen muchos menos efectos, pero pueden causar candidiasis oral si no se usa espaciador o no se enjuaga la boca.

Diagnóstico Diferencial

Es importante no confundir el asma con otras patologías que cursan con obstrucción bronquial: - **EPOC** (historia de tabaquismo, obstrucción persistente). - **Insuficiencia Cardíaca** ("asma cardíaca"). - Obstrucción de vía aérea superior (estridor). - **Reflujo Gastroesofágico** (causa común de tos crónica). - Disfunción de cuerdas vocales.

NOTA CLÍNICA

A diferencia del **EPOC**, el asma suele iniciarse en la infancia o juventud, se asocia a atopia (rinitis, dermatitis) y su obstrucción es marcadamente reversible.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Una madre consulta porque su hijo de 2 años se despertó a las 3 AM con tos perruna intensa, estridor y dificultad respiratoria. Los síntomas duraron aproximadamente 15 minutos y se resolvieron espontáneamente. El niño no presenta fiebre y actualmente se encuentra completamente asintomático. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Otras Causas de Disfonía Aguda. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Crup espasmódico: inicio y fin súbito, nocturno, sin fiebre, autolimitado y benigno (1-4 noches)
- El crup espasmódico se asocia a alergia, reflujo y virus diferentes a la parainfluenza
- Epiglotitis: infección bacteriana grave, clásicamente por *Haemophilus influenzae* tipo B
- Clínica de la epiglotitis: odinofagia, sialorrea, estridor, fiebre alta, aspecto tóxico-septico
- Posición de tripode y voz de papa caliente son signos característicos de la epiglotitis
- Radiografía lateral de cuello: signo del pulgar (epiglotitis) vs signo de punta de lápiz (crup viral)
- El manejo prioritario de la epiglotitis es la vía aérea (intubación por especialista) + antibióticos
- Antibiótico de elección en epiglotitis: ceftriaxona; agregar cloxacilina si riesgo de estafilococo

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (OTRAS CAUSAS DE DISFONIA AGUDA)

PREGUNTA 1

Una madre consulta porque su hijo de 2 años se despertó a las 3 AM con tos perruna intensa, estridor y dificultad respiratoria. Los síntomas duraron aproximadamente 15 minutos y se resolvieron espontáneamente. El niño no presenta fiebre y actualmente se encuentra completamente asintomático. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Laringitis obstructiva (crup viral) grado 2
- B) Epiglotitis por *Haemophilus influenzae* tipo B
- C) Crup espasmódico
- D) Cuerpo extraño en vía aérea
- E) Laringomalasia descompensada

PREGUNTA 2

Un niño de 5 años consulta en urgencias por odinofagia intensa de inicio rápido, sialorrea, fiebre de 39.5 grados y aspecto tóxico. Se observa en posición de tripode con el cuello en hiperextensión. Presenta estridor inspiratorio y voz apagada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la primera prioridad en el manejo?

- A) Laringitis obstructiva; nebulización con adrenalina
- B) Amigdalitis purulenta complicada; antibióticos orales
- C) Epiglotitis; asegurar la vía aérea con intubación por especialista
- D) Absceso periamigdalino; drenaje quirúrgico
- E) Crup espasmódico severo; dexametasona oral

PREGUNTA 3

Se realiza una radiografía lateral de cuello a un paciente con sospecha de epiglotitis. ¿Cuál es el hallazgo radiológico esperado y con qué diagnóstico diferencial no debe confundirse?

- A) Signo del pulgar; no confundir con el signo de punta de lápiz de la laringitis obstructiva
- B) Signo de punta de lápiz; no confundir con el signo del pulgar del crup espasmódico
- C) Desviación traqueal; no confundir con neumotorax
- D) Estrechamiento subglótico simétrico; no confundir con estenosis subglótica congénita
- E) Imagen en reloj de arena; no confundir con cuerpo extraño laríngeo

RESUMEN: OTRAS CAUSAS DE DISFONIA AGUDA

Esta clase aborda el diagnóstico diferencial de la laringitis obstructiva, incluyendo el crup espasmódico y la epiglotitis. El crup espasmódico se presenta con clínica similar a la laringitis obstructiva pero con inicio y fin súbito de los síntomas, de duración breve (minutos), autolimitado y benigno. Es típicamente nocturno, puede durar de 1 a 4 noches, y habitualmente cursa sin fiebre. Se asocia a causas como virus, alergia, reflujo gastroesofágico y ciertos alimentos. El manejo es observación y educación, con aire húmedo; solo se usa adrenalina y dexametasona si llega muy obstruido a urgencias. La epiglotitis es una infección bacteriana grave, clásicamente por *Haemophilus influenzae* tipo B (aunque con la vacunación han aumentado otras bacterias como estreptococos y estafilococos, y afecta más a adultos). Se presenta con odinofagia intensa, sialorrea (no puede tragar), seguido rápidamente de estridor y fiebre alta, con aspecto tóxico-septico. El paciente adopta la posición de tripode y presenta la característica voz de papa caliente. El diagnóstico de la epiglotitis es clínico, complementado con radiografía lateral de cuello que muestra el signo del pulgar (diferente del signo de punta de lápiz del crup viral). El tratamiento prioritario es el manejo de la vía aérea (intubación por especialista) y antibióticos endovenosos, siendo ceftriaxona el de elección. Si hay riesgo de estafilococo aureo (adultos), se agrega cloxacilina o cefazolina. La adrenalina y los corticoides pueden ayudar como medida complementaria aguda.